

 Osakidetza TXAGORRITXU OSPITALEA H. TXAGORRITXU	GUINEA IBAÑEZ DE GARAYO <i>Deiturak / Apellidos</i>
	LUIS MARIA <i>Izena / Nombre</i>
	TOMAS ALFARO, 0013 007 A 1008 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA) <i>Helbidea / Dirección</i>
URGENCIA	
URGENCIAS DE MEDICINA	

Historia Zk. / Nº Historia	IKK / CIC	Gizarte Segurantz Zk. / Nº Seguridad Social	Jaiotze Data / F. Nacimiento
536665	1164816	10015586764	15/05/1956
Gertakari Zk. / Nº Episodio	Sarrera Data / F. Ingreso	Alta Data / F. Alta	Zerbitzu / Servicio
2554561	17/05/2020 16:40	17/05/2020 19:38	URGENCIAS GENERALES

Profesional / Profesional
ESTRECHA DIAZ, SANDRA

Varón de 64 años que acude por palpitaciones.

ANTECEDENTES PERSONALES:

- Sin alergia medicamentosas conocidas.
- HTA y dislipemia en tratamiento farmacológico.
- Primer episodio de FA, revertida con Vernakalant en octubre 2019. Posterior control en CCEE de Cardiología; ecocardiograma en nov/2019 con FE conservada, AI dilatada ligera. Dado de alta en abril/2020.
- Accidente de bicicleta en el año 2003: TCE grave con fractura de base craneal y fractura temporal izquierda. Hematoma epidural temporal izquierdo. Hematoma subdural temporo-parietal izquierdo. Hemorragia subaracnoidea traumática. Importante desviación de línea media con borramiento de cisternas basales. Preciso tratamiento de rehabilitación por presentar una afasia mixta de predominio motor. Discreta hemiparesia derecha.
- Epilepsia. Última crisis en 2010, generalizada tónico clónicas.
- Fístula arteriovenosa dural del seno sigmoide derecho tratada endovascularmente 17 de septiembre de 2018. En control por neuroradiología. Ingresó en junio/19 para control angiográfico con resultado de correcta embolización.

- Antecedentes quirúrgicos: Varices (Dic 2017). Sutura tendón mano 2017 con AG, evacuación de hematoma subdural y epidural y craneotomía descompresiva por TCE grave en 2003. Fractura humero.

- Tratamiento habitual (conciliado):

Atenolol 100 mg: 1-0-0
 Felodipino 5 mg: 1-0-0
 Simvastatina 20 mg: 0-0-0-1
 Lamotrigina 100mg: 1-0-1
 Lorazepam 1 mg: 0-0-0-1

ENFERMEDAD ACTUAL:

Acude por palpitaciones de comienzo hace 1 hora mientras estaba hablando por teléfono. No esfuerzo previo. Niega dolor torácico o disnea. No edemas en EEII ni datos de IC. Afebril.

EXPLORACIÓN GENERAL:

Consciente y orientado. Buen estado general. Bien hidratado y perfundido. Eupneico en reposo.

- Constantes vitales:

- Temperatura: 36.1 °C.

010104325 ESTRECHA DIAZ, SANDRA	FIRMADO:	FECHA INFORME: 17/05/2020
		HORA INFORME: 20:07
		PÁGINA: 1 / 4
		15

**Osakidetza**TXAGORRITXU OSPITALEA
H. TXAGORRITXU**GUINEA IBAÑEZ DE GARAYO**
*Deiturak / Apellidos***LUIS MARIA**
*Izena / Nombre***TOMAS ALFARO, 0013 007 A**
1008 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)*Helbidea / Dirección***URGENCIA****URGENCIAS DE MEDICINA**

- Tensión Arterial: 124/90 mmHg --> 131/86
- Pulso: 108 lpm --> 84 lpm
- Frecuencia respiratoria: 18 r.p.m.
- Pulsioximetría: 95 % aire ambiente.

- AP: murmullo vesicular conservado
- AC: arritmico, no ausculto soplos
- Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación.
- EELL: edemas crónicos sin fovea; datos de insuficiencia venosa crónica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

- ECG: fibrilación auricular a 116 lpm, QRS estrecho, eje izquierdo. Sin alteraciones en la repolarización.

- Analítica sanguínea:**BIOQUÍMICA SUERO**

Srm-Glucosa	89 mg/dL	60 - 110
Srm-Urea	31 mg/dL	10 - 50
Srm-Creatinina	0,90 mg/dL	0,5 - 1,4
Srm-Sodio	140 mEq/L	135 - 146
Srm-Potasio	4,0 mEq/L	3,5 - 5,5
Srm-Cloruro	106 mEq/L	95 - 110
Srm-Proteína C reactiva (PCR)	1,7 mg/L	0,00 - 5,00

Pla-Péptido natriurético B (BNP) 66 pg/mL 10 - 100

Srm-Troponina I cardiaca ultrasensible (TNI) 7 ng/L 0 - 34,2

HEMATOLOGÍA GENERAL**San-Hemograma**

San-Hematíes	5,15 *10 ⁶ /μL	4,5 - 5,9
San-Hemoglobina	16,9 g/dL	13 - 17,7
San-Hematocrito	49,2 %	40 - 53
San-Volumen corpuscular medio (VCM)	95,4 fL	78 - 101
San-Amplitud de distribucion eritrocitaria		
(ADE) 11,6 %	11,5 - 14,5	
San-Hemoglobina corpuscular media eritrocitaria		
(HCM) 32,8 pg	27 - 33	
San-Concentración de hemoglobina corpuscular		
media 34,4 g/dL	30,5 - 35,5	
San-Plaquetas	212 *10 ³ /μL	100 - 450

FIRMADO:

010104325 ESTRECHA DIAZ, SANDRA

FECHA INFORME: 17/05/2020**HORA INFORME:** 20:07**PÁGINA:** 2 / 4



Osakidetza

TXAGORRITXU OSPITALEA
H. TXAGORRITXU

GUINEA IBAÑEZ DE GARAYO
Deiturak / Apellidos

LUIS MARIA
Izena / Nombre

TOMAS ALFARO, 0013 007 A
1008 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)

Helbidea / Dirección

URGENCIA

URGENCIAS DE MEDICINA

San-Volumen medio plaquetario	* 6,5 fL	7,4 - 11
San-Leucocitos	5,47 *10 ³ /μL	4 - 11
San-Formula leucocitaria		
San-Neutrófilos	52,10 %	30 - 70
San-Linfocitos	36,20 %	25 - 50
San-Monocitos	10,40 %	0 - 25
San-Eosinófilos	0,95 %	0 - 5
San-Basófilos	0,43 %	0 - 1
San-Neutrófilos	2,85 *10 ³ /μL	1,5 - 7,7
San-Linfocitos	1,98 *10 ³ /μL	1,1 - 4,5
San-Monocitos	0,57 *10 ³ /μL	0,1 - 1,0
San-Eosinófilos	0,05 *10 ³ /μL	0 - 0,5
San-Basófilos	0,02 *10 ³ /μL	0,0 - 0,2

HEMOSTASIA

Pla-Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) 34 sg	0 - 40	
Pla-Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA)(ratio) 1,09	0,00 - 1,30	
Pla-Tiempo de protrombina (sg)	10,90 sg	
Pla-Tiempo (Indice) de protrombina (%)	109 %	70 - 150
Pla-INR (Ratio Internacional Normalizada)	1,0	0,8 - 1,2
Pla-Fibrinogeno (derivado)	369 mg/dL	150 - 500

- Rx tórax PA y lateral: No se observan consolidaciones ni datos de IC

TRATAMIENTO RECIBIDO EN URGENCIAS:

- Vernakalant 74,25 ml a pasar en 10 minutos

EVOLUCIÓN:

Varón de 64 años con los antecedentes descritos que acude por palpitaciones de comienzo a las 16.00 h aprox, mientras estaba en reposo. No dolor torácico ni clínica de angina. No datos de IC.

En urgencias estable HD. AS sin alteraciones; ECG en fibrilación auricular a unos 120 lpm.

Se administra vernakalant (99Kg --> 1º perfusión 74.25 ml a pasar en 10 minutos), tras lo cual revierte a sinusal.

Paciente con CHADs-Vasc 1 (por HTA), por lo que se decide iniciar anticoagulación con ACOD. Filtrado glomerular 91,2 ml/min.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA:

- FIBRILACIÓN AURICULAR PAROXÍSTICA REVERTIDA FARMACOLÓGICAMENTE

FIRMADO:

010104325 ESTRECHA DIAZ, SANDRA

FECHA INFORME: 17/05/2020

HORA INFORME: 20:07

PÁGINA: 3 / 4



URGENCIA

URGENCIAS DE MEDICINA

LUIS MARIA

Izena / Nombre

TOMAS ALFARO, 0013 007 A
1008 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)

Helbidea / Dirección

- Iniciar Edoxaban 60 mg cada 24 horas (tomar a la misma hora). Iniciar hoy. Se entregan 2 comprimido en mano hasta confirmar visado.
- Se le avisará vía postal para cita en consulta de Hematología (Coagulación).
- IC a UCA para valorar cita en arritmias (ya está dado de alta del episodio previo).
- Control por su MAP.

FIRMADO:

FECHA INFORME: 17/05/2020

HORA INFORME: 20:07

PÁGINA: 4 / 4

15